

치골상부 도뇨관(SPT) 삽입술

환자 안내문 · 시술 전 알아야 할 사항

WARWIKI

치골상부 도뇨관(SPT)은 요도 대신 아랫배의 작은 구멍을 통해 방광에서 소변을 빼내는 부드러운 관입니다. 이 안내문은 삽입 이유, 준비 방법, 시술 과정을 설명합니다.

이 시술에 대하여

방광은 소변을 저장합니다. 소변이 정상적으로 배출되지 않거나 요도를 쉬게 해야 할 때, 아랫배를 통해 방광에 직접 도뇨관을 삽입합니다. 요도를 거치지 않으므로 장기 사용 시 더 편안하고 요도에 부담이 적습니다.

다음과 같은 경우에 권장됩니다:

- 스스로 소변을 볼 수 없어 방광을 비워야 할 때
- 수술 또는 외상 후 요도를 쉬게 하거나 보호할 때
- 신경성 방광 등으로 장기 배뇨가 필요할 때
- 요도 카테터로 인한 자극을 피하고 싶을 때
- 성생활을 유지하거나, 관을 막아 배뇨 기능을 테스트할 때

안전한가요?

네, 일반적으로 안전한 시술입니다. 방광을 채워 복벽 쪽으로 올라오게 한 뒤, 초음파 및/또는 소형 카메라로 유도하여 장을 피해 삽입합니다. 약간의 출혈, 경미한 불편감, 방광 경련 등은 흔하며 금방 회복됩니다. 이전에 복부·골반 수술을 받은 경우 반드시 미리 알려주세요.

용어 설명

치골상부(Suprapubic)

치골 바로 위, 아랫배 부위 — 관이 나오는 위치입니다.

방광(Bladder)

소변을 저장하는 기관입니다.

도뇨관(Catheter)

소변을 빼내는 부드러운 관. 치골상부 도뇨관은 요도 대신 아랫배로 드레인합니다.

요도(Urethra)

소변이 몸 밖으로 나오는 관. 치골상부 도뇨관은 요도를 우회합니다.

국소마취

피부에 주입하는 마취제로 해당 부위의 통증을 없앱니다.

진정 / 마취

긴장을 풀거나 잠들게 하는 약물(전신마취 포함)입니다.

초음파 / 카메라

음파 영상 또는 방광 내 소형 카메라로 관을 안전하게 유도하는 도구입니다.

방광 경련

시술 후 흔히 나타나는 갑작스러운 방광 수축 — 치료로 완화됩니다.

아픈가요? 방법에 따라 다릅니다. 국소마취 후 진정을 사용하거나, **전신마취 또는 척추마취**를 사용하기도 합니다. 어떤 마취 방법을 사용할지는 의료진이 안내합니다. 시술 후 방광 경련이나 삽입 부위의 약한 통증은 정상입니다. 시술 시간은 약 15-30 분입니다.

준비 방법

- **요청 시 방광을 채운 상태로 오세요** — 삽입을 더 안전하게 합니다. 물을 마시고 참거나, 시술 시작 시 의료진이 채울 수도 있습니다.
- **금식 지시를 따르세요** — 진정 또는 전신마취를 받는 경우, 수 시간 전부터 음식·음료를 삼가야 할 수 있습니다.
- **귀가 도움을 미리 준비하세요** — 진정을 받을 경우 혼자 운전하실 수 없습니다.

다음 사항은 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- 복부·골반 수술 경험 — 흉터 조직이 삽입 경로에 영향을 줄 수 있습니다
- **혈액 희석제 복용** 또는 출혈 이상 — 시술 전에 중단이 필요할 수 있습니다
- 임신 가능성, 감염, 마취제 또는 라텍스 알레르기

시술 과정

- 1 자세를 잡은 후 마취를 시행합니다 — 국소마취+진정, 또는 전신마취·척추마취. 이후 아랫배를 소독합니다.
- 2 방광에 액체를 채워(이미 차 있지 않은 경우) 복벽 쪽으로 올라오게 하여 장과의 거리를 확보합니다.
- 3 초음파 및/또는 방광 내 소형 카메라로 유도하면서, 치골 바로 위에 작은 절개를 내고 관을 방광 안으로 삽입합니다.
- 4 방광 내 작은 풍선을 부풀려 관을 고정하고, 배액 백에 연결합니다.

시술 후

- 소변은 백으로 배출됩니다. 퇴원 전 **관과 피부 관리 방법**을 의료진이 알려드립니다.
- 하루 이틀간 약간의 통증, 방광 경련, **소량의 혈뇨**는 흔한 증상입니다.
- **첫 도뇨관 교체는 의료진이** 약 4-6주 후에 시행합니다. 관이 빠지면 즉시 연락하세요 — 삽입 통로가 몇 시간 안에 막힐 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 관이 **빠지거나** 배액이 멈출 때(백에 소변이 없을 때)
- 복통이 심해지거나 부기, 심한 출혈이 있을 때
- 소변이 탁하거나 악취가 날 때(감염 징후)

기억할 세 가지

1. 치골상부 도뇨관(SPT)은 요도를 우회하여 아랫배의 작은 구멍으로 방광을 비우며, 장기 사용 시 더 편안합니다.
2. 준비: 요청 시 방광을 채운 상태로 오고, 금식 지시를 따르고, 진정 시 귀가 도움을 준비하고, 복부 수술·혈액 희석제·임신 가능성을 미리 알려주세요.
3. 국소마취+진정 또는 전신마취로 시행합니다. 의료진이 관리 방법을 알려드리며, 첫 교체는 4-6주 후입니다. 관이 빠지거나 발열이 생기거나 소변이 나오지 않으면 즉시 연락하세요.